

Anamnèse et théorie

Table des matières

0) Structure.....	1
1) Présentation/accueil.....	2
2) Anamnèse actuelle.....	2
3) Les caractéristiques d'un symptôme.....	2
4) Anamnèse par systèmes.....	4
5) Antécédents personnels.....	7
6) Anamnèse psychosociale combinée.....	7
7) Antécédents familiaux.....	8
8) Traitements.....	9
9) Clôture.....	9
10) Théorie.....	9
10.1) Douleurs thoraciques.....	9
10.2) La dyspnée et ses stades NYHA.....	10
10.3) La toux.....	12
10.4) Hémoptysies.....	13
10.5) Douleurs oesophagiennes et sous-diaphragmatiques.....	13

0) Structure

Définitions :

- 1) Présentation/accueil
- 2) Anamnèse actuelle
- 3) Les caractéristiques d'un symptôme
- 4) Anamnèse par systèmes
- 5) Antécédents personnels
- 6) Anamnèse psychosociale combinée
- 7) Antécédents familiaux
- 8) Traitements
- 9) Clôture

Remarque 1 : lorsque le patient parle de **ses maladies, traitements, ou ceux de sa famille**, toujours s'intéresser à la **survenue** (= le facteur déclenchant) de la maladie, l'**âge** auquel elle a commencé, la **durée** de celle-ci, si elle s'est **reproduite** (si oui combien de fois, si c'était pire, etc.), s'il s'en est bien remis/le vit bien (= **évolution**) et toujours essayer de demander au patient **ce qu'il ressent** vis-à-vis de cette maladie/traitement, si c'est quelque chose de grave ou qui l'affecte (ex. : infarctus du frère, traitement de chiomiothérapie, etc.)

Remarque 2 : lorsqu'on pose des questions sur les maladies, les traitements, la consommation de tabac, etc., ne pas oublier de préciser leur évolution et l'âge auquel on l'a commencé

1) Présentation/accueil

Pour accueillir le patient, se lever, aller vers lui, lui serrer la main (et éventuellement l'inviter à s'asseoir) et se présenter en donnant son nom et sa fonction et finalement lui demander la confirmation de son identité. On demande ensuite au patient si on a son accord pour que ce soit nous qui l'ausculterons (« Est-ce que vous êtes d'accord que je m'occupe de vous aujourd'hui ? »).

Il est important de commencer par une question ouverte (la même que dans le point suivant en fait). On demande alors si le patient a des soucis particuliers ou des souhaits (typiquement des soucis familiaux, du travail ou des craintes personnelles). Ensuite, si c'est le cas, on peut préciser au patient qu'on a déjà reçu quelques informations sur lui et qu'on est au courant de [problèmes], rappeler le sujet et les raisons de ses éventuelles dernières visites.

Ensuite, une fois ces éléments recueillis, il est capital d'établir un agenda en indiquant l'ordre des priorités ainsi que les différents points abordés (= quelle anamnèse), tout en intégrant tout ce que le patient vient de dire (= on ne va donc que répéter tout ce que le patient a dit et ce qui est prévu) ! Une fois cela fait, il faut lui demandeur son accord, si cela lui convient et si éventuellement il aurait vu les choses autrement (« Qu'avez-vous imaginé ce que nous puissions faire ? ») ou aurait envie de rajouter quelque chose, d'aborder un sujet supplémentaire, s'il aurait des souhaits quant à un thème particulier, si on aurait oublié quelque chose, s'il aimerait aussi parler d'un point plus émotionnel ou psychologique, etc.

Une fois tous ces points abordés, on fixe le temps dont on dispose pour couvrir tout le sujet pour éviter des malentendus.

Pour cette année, si les paramètres vitaux ne sont pas donnés (= température, tension, poids, fréquences respiratoire et cardiaque), il faut les prendre nous-même.

2) Anamnèse actuelle

Phrase d'accroche : « Dites-moi ce qui vous amène. ». Ensuite, il est très important de s'accorder avec le patient de ce sur quoi sera centré toute notre anamnèse, afin d'éviter des confusions ou de passer à côté de la raison de la venue du patient.

Motif de consultation :

- 1) Plainte, souffrance (patient atteint dans sa santé)
 - Si le patient évoque une douleur par un terme spécial (« J'ai une crise de foie »), essayer de d'abord comprendre ce qu'il entend par ce terme, qui est souvent différent de sa signification réelle
- **2) Bilan de santé (patient peut être en bonne santé)**
 - **(On y retrouve surtout le bilan psychosocial !)**

3) Les caractéristiques d'un symptôme

On ne le fait pas dans le cas d'un bilan de santé !

« Parlez-moi un peu plus de cette douleur. »

- 1) Localisation et irradiation
 - L'irradiation est une question importante qui doit être en accord avec la douleur, c'est-à-dire qu'il faut la relier à un symptôme possible causé par cette douleur. Il ne suffit pas de demander « Est-ce que la douleur se diffuse autour de ce point ? », mais il faut proposer des chemins qu'elle pourrait prendre (« Est-ce qu'elle vous va jusque dans le bras ? Est-ce qu'elle se projette jusque dans le côté gauche de votre ventre ? »). Ne pas hésiter à montrer avec les mains en accompagnant la parole et à demander au patient de localiser l'épicentre de la douleur, ainsi que son irradiation avec des gestes.
- 2) Qualité (serrement, colique, brûlure, décharge électrique, piquûre, coup de poignard, déchirement, etc.)
- 3) Intensité (échelle de 0 à 10)
 - Exemplifier l'échelle ou au moins dire « 0 étant une absence de douleur et 10 une douleur insoutenable/la pire douleur qui soit ». Il est aussi important de se renseigner si la douleur évolue avec le temps, par exemple si elle augmente avec le temps (= va en crescendo) ou si elle reste identique, se calme avec le temps, etc.
La douleur est aussi un point important où demander comment le patient se sent vis-à-vis d'elle et comment il vit cette douleur !
- 4) Chronologie (début, fin, durée, fréquence)
 - Essayer d'approfondir les conditions de survenue, pour savoir si la douleur apparaît avec un effort (si oui quel genre), si elle apparaît au repos, dans une certaine position, avec le froid, quand on avale, avec certains mouvements, après manger, etc. Demander si la douleur apparaît aussi lorsqu'on presse sur le point douloureux ou non, pendant la respiration, etc.
- 5) Condition de survenue
 - Qu'est-ce qui a déclenché ce problème ? Depuis quand est-il apparu, pourquoi et a-t-il évolué depuis ? Faire des liens !
- 6) Facteurs le modifiant (aggravant ou soulageant)
- 7) Manifestations associées = autres douleurs/éléments liés au problème
 - Par exemple, de l'asthme et de la toux, des 'fausses routes' et des brûlures d'estomac, de la sueur avec une douleur intense, des nausées avec des étourdissements, etc.
- 8) Première fois ?
 - Question **capitale**, à toujours poser !
- 9) Est-ce qu'il se serait passé quelque chose les heures/jours/semaines avant ?
 - Question **capitale**, à toujours poser !
- Bonus :
 - 1) Comment le patient vit-il la douleur ?

- 2) Est-ce que c'est la première fois que ces douleurs apparaissent ? Si non, creuser vers les hospitalisations, opérations, etc.
- 3) Est-ce que la situation a évolué entre avant et maintenant ?
- 4) Un membre de la famille aurait-il déjà été touché par cette maladie ?
- 5) Avez-vous déjà pris des médicaments depuis ? Si oui, ont-ils eu un effet sur cette douleur ?
- 6) Est-ce qu'il y aurait eu un événement précédent cette douleur/quelque chose de particulier qui se serait passé dans les derniers mois/semaines/jours ?

À la fin, toujours faire une synthèse pour s'assurer (et recevoir sa confirmation) qu'il n'a pas fait d'erreur dans l'énonciation de son problème sur n'importe lequel des points.

Demander au patient si, éventuellement, il n'aurait pas remarqué quelque chose de bizarre ou de paradoxal concernant ces douleurs et d'éventuels symptômes associés (une perte de poids associée à ses douleurs de ventre, mais un sentiment de ballonnement par exemple).

4) Anamnèse par systèmes

Dans chacun des différents systèmes, on va s'intéresser à caractériser chaque symptôme selon le même schéma que celui pour caractériser la douleur (dans la mesure du possible ; ex. : dans une dyspnée, on ne peut pas avoir de localisation !) ! Il est aussi important de demander :

- Réponse au traitement, pour savoir si elle influe sur son/ses symptômes
- Symptôme en aggravation ou en diminution
- Symptôme permanent ou intermittent
- Symptôme diurne ou nocturne

- Général
 - Aspect général (vieille dame toute coquette = elle arrive très bien à s'occuper d'elle-même !)
 - État général
 - État mental
 - Humeur
 - Contenu de la pensée (= est-ce que la personne pense clairement/n'est pas en train de délirer ?)
 - Jugement (= est-ce que la personne est bien orientée dans le temps et l'espace et comprend ce qu'il se passe ?)
 - Discernement (= capacité à agir sans une influence externe)
 - BMI (avec perte, gain et cinétique du poids)
 - Signes vitaux (température, TA, fréquences respiratoire et cardiaque)

- Hydratation et sudation
- Adénopathies
- Peau
- Cardio-vasculaire°
 - Douleurs thoraciques
 - Palpitations (= coeur qui bat trop/pas assez vite et irrégulièrement)
 - Dyspnée¹ (sa qualité signifie qu'on recherche des expectorations et bruits pulmonaires surajoutés)
 - Orthopnée
 - Dyspnée paroxystique nocturne
 - Pollakiurie nocturne
 - Varices
 - Douleurs des membres inférieurs
 - Oedèmes des membres inférieurs
 - Ulcères
 - Doigts blancs, bleus (= cyanose), lésions, etc.
 - Syncope (son intensité signifie qu'on cherche à savoir combien de temps elle a duré. Une durée courte de quelques minutes est plutôt cardiaque, sinon on a plutôt une cause neurologique)
 - Rechercher les principaux facteurs risques, notamment : âge, histoire familiale (= parent avec un problème CV à un jeune âge (~ sous les 60 ans)), HTA, tabagisme, alcoolisme, hypercholestérolémie (si connue), IMC, sédentarité, diabète, insuffisance rénale
 - En cas de suspicion d'IC, demander :
 - 1) Arrive à lacer ses chaussures/à se pencher en avant
 - 2) Arrive toujours à fermer sa ceinture
 - 3) Mange bien
 - 4) Dors bien
- Pulmonaire°
 - Douleurs thoraciques
 - Dyspnée² (sa qualité signifie qu'on recherche des expectorations et bruits pulmonaires surajoutés)

° Note : dans une anamnèse cardio-pulmonaire, il est nécessaire de faire une anamnèse ORL et abdominale, certains aspects abdominaux et ORL pouvant s'y retrouver (ex : reflux qui ressemble à infarctus !)

1 Stades NYHA et sensations différentes de dyspnée 10.2

° Note : dans une anamnèse cardio-pulmonaire, il est nécessaire de faire une anamnèse ORL et abdominale, certains aspects abdominaux et ORL pouvant s'y retrouver (ex : reflux qui ressemble à infarctus !)

2 Stades NYHA et sensations différentes de dyspnée 10.2

- Toux³
- Expectorations (volume et couleur)
- Hémoptysies⁴
- Asthme (et facteurs déclenchants)
- Ronflements (explorer les symptômes nocturnes (= réveils répétés, sensation d'étouffement, sudation, etc.) et diurnes (= fatigue, irritabilité, problèmes mnésiques ou de concentration, etc.))
- Digestif
 - Dysphagies (= fausses-routes ; pour les solides et/ou les liquides)
 - Nausées et vomissements
 - Pyrosis⁵
 - Réplétion gastrique
 - Douleurs abdominales
 - Selles (fréquence, qualité, sang, couleur et incontinence)
 - Ictère
- Génito-urinaire
 - Douleurs dans les loges rénales
 - Urines (fréquence, quantité, couleur et odeur)
 - Fonctions sexuelles, libido, douleurs
 - Pertes vaginales
 - Menstruations (début, fin, aménorrhée et dysménorrhée)
- Neurologique
 - Acuités visuelle et auditive
 - Vertiges
 - Céphalées
 - Épilepsies
 - Troubles de la sensibilité
 - Troubles moteurs
 - Troubles de l'équilibre
 - Douleurs (brûlures ou électriques)
 - Troubles cognitifs
- Ostéo-articulaire

³ Caractérisation spéciale décrite en 10.3

⁴ Caractérisation décrite en 10.4

⁵ Caractérisation décrite en 10.5

- Douleur articulaire
- Oedème, rougeur articulaire
- Limitation fonctionnelle d'un membre
- Douleur « osseuse »
- Perte de taille (> 4cm)
- Dermatologie
 - Éruption cutanée, plaque rouge
 - Dyscoloration cutanée
 - Boutons
 - Pilosités
 - Lésions cutanées
- Psychiatrie
 - Anxiété et dépression
 - Comportements à risque (abus de substances)
 - Troubles du caractère
 - Éléments de la lignée psychotique (fuite des idées, hallucinations et hypomanies)

5) Antécédents personnels

- Les maladies et leurs traitements
 - Dans les maladies, ne surtout pas oublier de maladies chroniques/qui récidiveraient souvent, et donner un exemple/bien expliquer ce qu'on entend par ces deux types de maladies.
- Les accidents et les blessures
- Les opérations
- Les hospitalisations
- La dernière fois que la personne est allée chez le médecin, quand et pourquoi

6) Anamnèse psychosociale combinée

- État général ressenti par le patient (physique et mental)
- La situation à domicile
 - Demander où la personne vit (et si dans un immeuble à quel étage et si cet immeuble comporte un ascenseur), avec qui et ses conditions de vie.
- La situation conjugale
 - Demander si la personne est mariée ou est avec quelqu'un et éventuellement se renseigner si tout va bien dans cette relation. Se renseigner sur d'éventuels divorces et s'ils ont eu un effet sur le moral ou la manière de vie de la personne.

Se renseigner sur quelque chose que son conjoint aurait remarqué de bizarre/lui aurait fait remarquer/lui aurait souvent répété.

- Les enfants et la famille (et chien s'il en a un :))
 - Se renseigner sur leur âge (adolescents => peuvent être difficiles à vivre), la relations parent-enfant et inversement, leur départ de la maison (qui pourrait rendre les parents tristes, inquiets, etc.), un éventuel décès dur à supporter, etc. Par extension, se renseigner sur d'éventuelles mauvaises relations familiales, des événements familiaux durs à supporter (décès d'un proche, annonce d'un cancer, etc.).
- Emploi
 - Demander ce qu'il en est des horaires, des charges, du stress, de la qualité de son environnement, d'éventuels longs trajets, etc.
- (La vie au quotidien) (sauf si intéressant)
 - Description d'une journée typique (ou en tout cas de phases qui pourraient être intéressantes), de son rythme de vie et d'activités spéciales dans la semaine.
- (Habitudes alimentaires) (sauf si intéressant)
- Mode de vie
 - Est-il végétarien ? Sportif ? Gamer accro ? Apathique ? Etc.
- Les vaccinations
 - « Est-ce que votre carnet de vaccinations est à jour ? »
- Voyages
- Exercices et loisirs
- Allergies
- Alcool, tabac et stupéfiants
 - Dans ce cas là, toujours demander la quantité de produit consommée par jour (= si le patient dit « Un peu », ça veut dire combien précisément ?) et depuis combien de temps. On peut aussi utiliser le système UPA avec le tabac, c'est-à-dire qu'on demande au patient combien de paquets il consomme par jour et depuis combien de temps il a commencé à consommer => 10 UPA = 1 paquet/jour pendant 10 ans.
- Risques liés à l'environnement = est-ce que quelque chose dans l'environnement de vie de la personne pourrait expliquer son problème
- (Vie sexuelle) (à bien amener et n'en parler que si la situation semble propice (ex. : vieux de 60 ans, divorcé, qui part seul au Vietnam... Suspect non ?))
- Les opinions du patient
 - Très important dans la médecine actuelle ou l'avis du patient compte. De plus, s'il a lui-même l'occasion de s'essayer à poser son diagnostic ou encore à trouver des corrélations, il n'en sera que plus heureux et satisfait (ou en tout cas intrigué). Ce point peut aussi livrer de nouvelles informations sur des relations inattendues que le patient aurait lui-même faites et à côté desquelles on serait passé (« Avez-

vous une explication vous-même ? Qu'est-ce que vous imaginez comme cause pour [] ? »).

- Relier des activités à son problème
 - S'il a eu de l'asthme dans son enfance et que, soudain, en allant faire les foins, il a de la peine à respirer, mais qu'il pensait que ça pourrait venir du faire de l'exercice et non de faire les foins !

7) Antécédents familiaux

- (Pathologies retrouvées dans la famille) => trop vague, à bannir, car le patient ne sait pas où on veut en venir. Il faut bien l'aiguiller et poser des questions sans équivoque.
- Pathologies (et causes de décès) des parents et grands-parents
 - Attention au fait de parler de ses beaux-parents ! Ils ne font pas partie de la famille, mais ça peut être un piège !
- Pathologies chez les frères et sœurs
- Pathologies chez les enfants

8) Traitements

- Le traitement régulier
- Les traitements occasionnels
- Les « substances annexes » (vitamines, plantes, etc.)
 - Il est utile de nommer les différentes possibilités, les patients n'y pensant pas forcément eux-mêmes ou ne comprenant pas la question (toujours éviter d'être vague !).

9) Clôture

Résumer les points importants avec le patient et s'assurer de n'avoir raté aucune information capitale et assurer qu'on a bien compris son problème et qu'on va y donner suite (« J'ai tout à fait compris vos inquiétudes/vos douleurs/votre ressenti vis-à-vis de votre maladie et je me chargerai d'assurer la transmission de tout le contenu de notre entrevue d'aujourd'hui au Dr ... »). Il faut aussi s'assurer que le patient a bien tout compris si des traitements sont donnés et **surtout** ne pas oublier de lui demander avant de partir s'il n'aurait pas oublié de parler de quelque chose qui le gênerait ou s'il aurait oublié un détail, ou encore s'il aimerait parler d'un autre problème qui lui pèse. Finalement, lui affirmer qu'on reste entièrement à sa disposition s'il a un doute, un problème, une douleur, etc. et qu'il aimerait venir nous en parler

10) Théorie

10.1) Douleurs thoraciques

De manière générale, on notera que les douleurs cardiaques et pulmonaires et l'intensité de leur symptômes ne sont en général pas toujours corrélés avec l'intensité de la maladie ! Par exemple, les patients diabétiques ressentent souvent assez peu la douleur et ont donc une présentation totalement atypique des infarctus.

Une douleur thoracique ne reflète pas toujours une atteinte d'un organe thoracique ; en effet, la douleur référée de nombre de problèmes digestifs (calculs biliaires, estomac, etc.) ont leur irradiation dans la partie thoracique ! De même certaines douleurs thoraciques, par exemple celle de l'oesophage, sont trompeuses, irradiant dans les mêmes endroits que ceux d'un infarctus typique ! On notera d'ailleurs que comme les poumons sont très peu innervés côté sensibilité, leur lésion ne provoque en général aucune douleur (mais une lésion de la plèvre oui) !

Certaines douleurs pulmonaires particulières sont accentuées par la toux ou les mouvements respiratoires :

- Toux : la trachéobronchite et les douleurs neurologiques (= compressions des nerfs rachidiens ou de leur racines ; ex. : sciatique)
- Respiratoire (ici tout ce qui touche la plèvre) : le pneumothorax, la pleurésie, la pneumonie, l'embolie pulmonaire (= fait un infarctus du poumon, qui peut aller jusqu'à la plèvre et déclencher des douleurs), les cancers pleuraux infiltrants et les mésothéliomes pleuraux

On peut retrouver plusieurs catégories de douleurs thoraciques typiques :

- Pariétales (ex. : fracture costale ou tendinite) : elles sont typiquement mécaniques (= se déclenchent au mouvement) et sont reproductibles à la palpation. Elles se présentent souvent avec une rougeur ou une voussure de la zone touchée
- Neurologiques (ex. : fracture vertébrale, hernie discale, zona, maladie de Lyme, etc.) : elles sont typiquement en ceinture ou en hémi-ceinture, partant du dos pour aller vers la poitrine. On retrouve souvent des troubles de la sensibilité concomitants et des exacerbations avec la toux
- Anxieuses : elles sont typiquement décrites très précisément, pointées du doigt, souvent en direction du coeur. Ce sont des douleurs qui vont et viennent et on remarque une discrétion entre l'intensité que leur donnent les patients (« Elle est à 10/10 ! ») et leur aspect (sourient, ne semblent pas gênés, etc.). Elles sont généralement très brèves, ne réveillent pas les patients la nuit et n'ont pas de facteurs déclenchant particulier

Pour correctement classer les douleurs thoraciques et poser un diagnostic, comme énormément de causes, thoraciques ou non, peuvent les déclencher, il est donc indispensable d'essayer de rassembler tous les symptômes sous un seul chapeau tout en reliant cette douleur et ses symptômes avec les caractéristiques de la plainte, l'âge, le sexe, les facteurs de risque, les antécédents personnels et familiaux. Du coup, même si un symptôme semble être totalement typique de notre problème (ex. : brûlure rétro-sternale qui irradie dans le bras gauche), il faut que tout colle ensemble (ex. : aucun FRCV avec une brûlure rétro-sternale qui irradie dans le bras gauche et des antécédents de reflux gastro-oesophagien pointerait plutôt vers un reflux qu'un infarctus !) !

Pour avoir une béquille sur laquelle s'appuyer dans les cas complexes, on peut utiliser des scores diagnostics, qui vont nous donner une probabilité pré-test par exemple d'embolie pulmonaire => on peut ensuite utiliser d'autres tests biologiques (= examens complémentaires) pour augmenter ou au contraire diminuer la probabilité post-test. Il est très important de noter à ce niveau-là qu'un score ne permet jamais de donner un traitement, il ne sert qu'à débrouiller les cas très probables des peu probables, et que la clinique est toujours supérieure en terme de suspicion qu'un examen

complémentaire (ex. : si la suspicion pour une EP est forte et qu'un test aux D-Dimères revient négatif, la suspicion reste très forte !).

10.2) La dyspnée et ses stades NYHA

Tout d'abord, il est important de préciser que la dyspnée est un sentiment purement subjectif d'inconfort respiratoire, une « peine à souffler », donc seul le patient peut nous dire si oui ou non il souffre de dyspnée. Elle n'est donc pas liée étroitement avec le VEMS, la PaO₂ ou la PaCO₂, mais fortement avec l'intensité de l'effort des muscles inspiratoires. On peut cependant la mesurer de manière objective via la classification du NYHA ou des questionnaires sur la qualité de vie ; il est aussi possible de la mesurer de manière subjective, avec l'échelle visuelle analogique ou l'échelle de Borg (= échelle logarithmique, correspondant mieux au sentiment de dyspnée, plaçant une forte dyspnée déjà au niveau du rang 5 sur 10).

On retrouve des sensations différentes suivant les problèmes à l'origine de la dyspnée :

- Effort respiratoire avec respiration difficile : typiquement après un exercice physique intense, ce qui est totalement normal et en général pas angoissant, sauf dans le cas où les personnes n'arrivent par exemple plus à monter les escaliers. C'est ce que les patients appellent « Avoir le souffle court »
- Soif d'air avec impression de suffocation : souvent retrouvé dans la BPCO et l'asthme, ce sentiment est très angoissant et vient surtout d'une augmentation de la PaCO₂ (=> pour l'expérimenter, retenir son souffle le plus longtemps possible)
- Serrement, poids sur le thorax : typique des maladies obstructives comme l'asthme ou la BPCO
- IC : sensation de suffocation, d'étouffement, de respiration lourde, que l'air ne rentre pas

On retrouve plusieurs causes classiques de dyspnée :

- Aigüe (= heures ou jours) :
 - Causes cardiaques : insuffisance VG (=> OAP), IC (rythmique, valvulaire ou ischémique), tamponnade, cardiopathie ischémique⁶ (SCA ou IM), etc.
 - Causes pulmonaires : asthme, obstruction VAS, pneumothorax, pneumonie, embolie, épanchement pleural, SDRA, etc.
- Chronique (= semaines ou mois) :
 - Causes cardiaques : insuffisance VG, IC (ischémique, valvulaire ou restrictive), HTP, etc.
 - Causes pulmonaires : BPCO, asthme chronique, pneumopathie interstitielle, scliose, affections neuro-musculaires, etc.
 - Causes ni cardiaques, ni pulmonaires : anémie, déconditionnement physique, myopathies, acidose métabolique (surtout les IR, acidoses médicamenteuses (ex. : metformine), diabète décompensé, etc.), etc.

⁶ La dyspnée est LE symptôme le plus manqué d'IM ou de SCA !

- Exacerbations : touchent surtout les maladies comme l'asthme, la BPCO, les pneumopathies interstitielles et la scoliose. Elles se produisent presque systématiquement à cause d'infections, mais peuvent aussi arriver en cas de pneumothorax, embolie, IC, etc.

Classification NYHA :

- Stade I : dyspnée uniquement à l'effort maximal = dyspnée normale
- Stade II : dyspnée d'effort, lors des efforts ordinaires, par exemple pour monter plus de deux étages
- Stade III : dyspnée au moindre effort, par exemple pour s'habiller, ou ne pas réussir à monter un seul étage
- Stade IV : dyspnée de repos

10.3) La toux

De manière générale, la toux chronique touche le plus souvent les femmes, surtout dans la tranche d'âge entre 40 et 70 ans.

On retrouve des récepteurs pour la toux dans tout l'arbre bronchique, mais également dans la plèvre, le péricarde, l'oesophage (RGO ! Le reflux peut être acide ou non), l'estomac, le tympan et le CAE ! Ceci montre donc qu'en cas de toux chronique, il faudra faire un examen ORL pour tout rechercher !

On la classe en 3 catégories :

- Aigüe (< 3 semaines) : vient le plus souvent d'infection des VAS par un virus (=> rhinite, sinusite, etc. = IVRS), ensuite plus rarement d'asthme, de présence d'un corps étranger, de pneumonie, etc.
- Subaigüe (entre 3 et 8 semaines) : vient le plus souvent en post-infectieux, lorsque l'infection et la fièvre ont disparu, mais la toux reste (= hyper-réactivité bronchique qui persiste)... On va faire une radio thoracique pour déterminer le problème, mais les causes les plus fréquentes sont les infections virales et bactériennes (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis (= coqueluche), etc.)
- Chronique (> 8 semaines) : le plus souvent, elle est causée par une coqueluche persistante, une (1) rhinorrhée postérieure (= rhinite + sinusite + obstruction nasale + écoulement postérieur), un (2) asthme, des (3) reflux gastro-oesophagiens (attention : la toux peut n'être que le seul symptôme ; pour le test d'épreuve, les IPP doivent souvent être donnés pendant 2 mois), un cancer pulmonaire, une fibrose pulmonaire, une bronchite chronique, mais aussi par certains médicaments (IECA).

Devant une toux chronique, il faut toujours faire une radiographie de thorax et une spirométrie (piège : asthme pas exclu, car il ne se manifeste que par crises !). Si on ne trouve toujours pas la cause, on va faire des traitements d'épreuve de chacune des 3 pathologies principales (ex. : pour l'asthme, on peut faire un test à la méthacholine ou donner ICS + LABA ; pour la rhinorrhée postérieure, on peut faire un traitement par ICS). Cependant, si le traitement IPP pour le RGO est négatif, mais que la suspicion de RGO reste forte, on peut faire une pH-métrie, une gastroscopie ou des tests de motilité oesophagienne

On caractérise une toux comme suit (= exactement comme une douleur) :

- 1) Ancienneté : aiguë ou chronique ?
- 2) Expectorations et couleur
- 3) Circonstances
 - Nuit (IC, asthme)
 - Lever (reflux gastro-oesophagien)
 - Matin (bronchite chronique)
 - Changement de position (pleural, reflux gastro-oesophagien)
 - Effort (IC, asthme)
 - Déglutition (fausses routes)
 - RGO (position-dépendant ou post-prandial)
 - Métier, loisirs, animaux, etc.
- 4) Signes associés
 - Respiration sifflante
 - Râles crépitants
 - Fièvre
 - Incontinence urinaire (à cause des augmentations répétées de pression)

Red flags concernant la toux :

- Exacerbation sévère
- Hémoptysie
- Suspicion d'inhalation de corps étranger
- Douleur thoracique
- Dyspnée
- État fébrile
- Suspicion de néoplasie

10.4) Hémoptysies

Faire attention au fait qu'on peut parfois avoir un épistaxis (= un saignement nasal) ou des hématoméses (= saignements du tube digestif) qui peuvent provoquer des hémoptysies, alors qu'on ne touche absolument pas la respiration !

Dans les causes principales des hémoptysies, on notera le cancer pulmonaire, les bronchiectasies, la tuberculose, les pneumonies, les bronchites aiguës, les aspergillomes et les embolies pulmonaires.

On les caractérise en 3 catégories, ces catégories ne renseignant pas sur la cause :

- Minime/crachats hémoptoïques : stries sanglantes sur un crachat muqueux ou purulent

- Moyenne : sang en quantité moyenne (~ moins d'1dl)
- Massive : > 200 à 600ml par 24h => urgence vitale, car risque d'asphyxie avec son sang !

10.5) Douleurs oesophagiennes et sous-diaphragmatiques

On en retrouve 3 types de douleurs oesophagiennes principales :

- Reflux gastro-oesophagien : brûlure rétro-sternale, souvent après un repas ou en lien avec. Il est déclenché par les changements de position ou certaines positions (couché ou penché en avant) et peut ne se manifester que par de la toux et de l'asthme
- Spasme oesophagien : douleur rétro-sternale constrictive, déclenchée par la déglutition. Elle est souvent brève et récidivante. Elle peut être calmée par la trinitrine, qui est un donneur de NO => énorme piège, car cette douleur irradie dans la même zone qu'une douleur coronarienne et peut être calmée par le même médicament !
- Rupture oesophagienne : douleur brutale, intense, de type déchirure, rétrosternale et basi-thoracique gauche, accompagnée de vomissements

On retrouve plusieurs lieux d'irradiation des douleurs sous-diaphragmatiques :

- Basi-thoracique : plutôt d'origine digestive
- Épaule droite : souvent d'origine hépatique
- Lombaire haute : souvent d'origine rénale ou biliaire